Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Respiratório

IVAS na Criança

Do resfriado ao estridor

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

IVAS na criança

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Quase toda IVAS é viral: suporte e orientação; antibiótico só para OMA confirmada, estreptococo provável e sinusite pelo tempo de evolução; estridor pede calma, dexametasona e, se moderado, adrenalina.

1. **Perigo:** não bebe, vomita tudo, convulsão, letargia, TEC > 2 s, gemência, estridor em repouso: referir.
2. **Resfriado:** 7–10 por ano; sem antibiótico, sem descongestionante de rotina; secreção verde não é bactéria.
3. **OMA:** abaulamento ou otorreia. Analgesia já. AIDPI: amoxicilina 50 mg/kg/dia por 8 dias, retorno em 2 dias.
4. **Observar a OMA** (AAP): unilateral não grave de 6–23 m e não grave ≥ 24 m. Bilateral < 2 anos ou grave: tratar.
5. **Garganta:** estreptococo = benzatina (< 20 kg 600 mil; ≥ 20 kg 1,2 milhão UI) ou amoxicilina 10 dias. ASLO não.
6. **Sinusite (ABR):** dupla piora após 5 dias ou sem melhora em 14. Sem RX. Amoxicilina 25–50 mg/kg/dia, 7–10 dias.
7. **Crupe:** dexametasona dose única para todos; moderado/grave + adrenalina 0,5 mL/kg (máx. 5 mL); observar 2–4 h.
8. **Não é crupe:** tóxico + saliva + sem tosse ladrante = epiglotite; sem resposta à adrenalina = traqueíte bacteriana.

Antibiótico na IVAS

Quadro	Veredito
Resfriado, rinite purulenta	Não
OMA confirmada	Sim, ou observar
Faringite viral	Não
Estreptococo provável	Sim, 10 dias
Crupe viral	Não

Pegadinha

SatO2 normal não descarta obstrução grave: a hipoxemia no crupe é tardia e já indica UTI.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço os sinais gerais de perigo
- ☐ Localizo o estridor pela voz e pela tosse
- ☐ Diagnostico OMA pelo abaulamento
- ☐ Sei quando observar e quando tratar a OMA
- ☐ Uso as pistas e o McIsaac na garganta
- ☐ Prescrevo benzatina pelo peso
- ☐ Sei os critérios de RSAB e os sinais orbitários
- ☐ Dou dexametasona e adrenalina no crupe
- ☐ Sei quando o estridor é epiglotite ou traqueíte